

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE ISQUEMIA DE HACHINSKI (HIS)

Eje V: Neurocognición y Demencias • Diagnóstico Diferencial de Etiología Vascular vs. Neurodegenerativa

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Isquemia de Hachinski (HIS; Hachinski Ischemic Score).
Nombre Original	Hachinski Ischemic Score (HIS; Hachinski et al., 1975).
Autores Originales	Vladimir C. Hachinski, M.D., L. D. Iliff, G. H. du Boulay, J. Marshall et al.
Adaptación Hispana	Pascual-Millán et al. (1993); Morís et al. (1995); Sociedad Española de Neurología (SEN).
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Demencias. Diferenciación etiológica entre demencia vascular y Alzheimer.
Tipo de Instrumento	Escala clínica de valoración heteroaplicada basada en anamnesis y exploración física.
Composición de Ítems	13 características clínicas objetivas con ponderaciones diferenciales (1 o 2 puntos).
Población y Rango	Adultos mayores (≥ 55 años) con síndrome demencial o deterioro cognitivo establecido.
Tiempo de Administración	5 a 10 minutos de cumplimentación tras historia clínica y examen neurológico.
Régimen de Licencia	Dominio público abierto para uso clínico asistencial, pericial y de investigación médica.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL MODELO ISQUÉMICO DE HACHINSKI

La **Escala de Isquemia de Hachinski** fue diseñada en 1975 por el neurólogo Vladimir Hachinski para resolver un desafío clínico crucial en psicogeriatría:

- Diferenciación Etiopatogénica Crucial:** En la década de 1970, la mayor parte de las demencias seniles se atribuían erróneamente a “arteriosclerosis cerebral”. Hachinski demostró que el daño vascular cognitivo se debe a **múltiples infartos cerebrales corticales y subcorticales** (demencia multinfarto), diferenciable de la degeneración cortical primaria de la enfermedad de Alzheimer.
- Semiología del Curso y Focalidad:** La demencia vascular se caracteriza por un debut abrupto, deterioro cognitivo a saltos (“en escalones”), fluctuaciones diurnas, labilidad emocional temprana y signos focales motores/sensitivos, a diferencia del declive insidioso, lento y continuo del Alzheimer.
- Guía para Intervención Preventiva:** Identificar el perfil vascular permite instaurar de inmediato prevención secundaria agresiva (antiagregación, control estricto de hipertensión, anticoagulación en fibrilación auricular).

3. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y PONDERACIÓN DE ÍTEMS (13 ÍTEMS / 18 PUNTOS)

Característica Clínica	Pon- deración	Criterios Médicos y Evidencia Exploratoria
1. Comienzo Brusco	2 puntos	Instauración súbita del déficit en cuestión de horas o pocos días.
2. Deterioro Escalonado	1 punto	Progresión a saltos con periodos intermedios de estabilización clínica.
3. Curso Fluctuante	2 puntos	Variaciones notables del rendimiento de una semana a otra o entre días.
4. Confusión Nocturna	1 punto	Desorientación y agitación crepuscular o nocturna desproporcionada.
5. Preservación Personalidad	1 punto	Mantenimiento del estilo relacional y empatía pese al déficit cognitivo.
6. Depresión	1 punto	Presencia de síntomas afectivos depresivos marcados tempranos.
7. Quejas Somáticas	1 punto	Cefaleas, mareos, acúfenos o quejas corporales reiteradas.
8. Incontinencia Emocional	1 punto	Risa o llanto espasmódico e involuntario sin causa aparente (afecto pseudobulbar).
9. Historia de HTA	1 punto	Hipertensión arterial documentada o en tratamiento farmacológico.
10. Historia de Ictus / ACV	2 puntos	Antecedente verificado de ictus isquémico o ataque isquémico transitorio.
11. Aterosclerosis Asociada	1 punto	Enfermedad coronaria, claudicación periférica o estenosis carotídea.
12. Síntomas Neurológicos Focales	2 puntos	Debilidad motora transitoria, disartria, disfagia o parestesias unilaterales.
13. Signos Neurológicos Focales	2 puntos	Hemiparesia objetiva, hiperreflexia asimétrica, signo de Babinski o hemianopsia.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y CORRELACIÓN NEUROPATOLÓGICA POST-MORTEM

La escala HIS cuenta con una de las validaciones de correlación anatómo-patológica más extensas de la neurología clínica:

Propiedad Metodológica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Concordancia Autóptica	Sensibilidad = 89%	Excelente capacidad para corroborar infartos cerebrales en biopsia/autopsia.
Especificidad Anatómica	Especificidad = 85%	Baja tasa de falsos positivos en casos confirmados de Alzheimer histopatológico.
Fiabilidad Interobservador	Kappa k = 0.82 - 0.88	Alta reproducibilidad entre neurólogos, geriatras y psiquiatras.
Concordancia con Neuroimagen	r = 0.76 (RMN/TAC)	Correlación directa con la carga lesional de leucoencefalopatía isquémica (Fazekas).
Estabilidad Temporal	CCI = 0.85 - 0.90	Puntuación estable o creciente conforme se acumulan eventos cerebrovasculares.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

- **Asignación Ponderada:** Cada uno de los 13 rasgos se puntúa como Ausente (0 puntos) o Presente (1 o 2 puntos según la clave técnica).
- **Cálculo de la Puntuación Total HIS:** Suma de las ponderaciones de todos los reactivos presentes:

$$\text{Puntuación Total HIS} = \sum_{i=1}^{13} \text{Ítem Presente}_i \quad (\text{Rango: 0 a 18 puntos})$$

- **Direccionalidad Diagnóstica:** A mayor puntuación, **mayor probabilidad de etiología cerebrovascular pura o multinfarto**; puntuaciones bajas (≤ 4) indican etiología neurodegenerativa primaria (Alzheimer).

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA

Estratificación	Rango HIS	Diagnóstico Probable	Perfil Fisiopatológico y Pronóstico Terapéutico
Perfil Degenerativo	0 a 4 pts	Enf. de Alzheimer	Proceso neurodegenerativo cortical puro (amiloide/tau); escasa carga vascular.
Perfil Intermedio	5 a 6 pts	Demencia Mixta	Coexistencia de patología Alzheimer y lesiones isquémicas subcorticales.
Perfil Isquémico	7 a 18 pts	Demencia Vascular	Etiología cerebrovascular multinfarto o enfermedad de pequeño vaso severa.

REGLA CLÍNICA DE ORO DE HACHINSKI (PUNTOS DE CORTE 4 Y 7):

- **HIS menor o igual a 4:** Alta certeza de demencia tipo Alzheimer primaria (especificidad $> 85\%$).
- **HIS mayor o igual a 7:** Alta certeza de demencia vascular pura o estado multinfarto.
- **HIS entre 5 y 6:** "Zona gris" altamente sugestiva de **Demencia Mixta**, la forma de presentación más común en mayores de 80 años en estudios neuropatológicos modernos.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE ACTUACIÓN CLÍNICA SEGÚN PUNTUACIÓN EN HIS

FLUJOGRAMA DE DECISIÓN TERAPÉUTICA BASADO EN HIS:

- **Paso 1 (Evaluación Inicial del Paciente con Demencia):** Registrar los 13 ítems con anamnesis al cuidador y exploración neurológica minuciosa.
- **Paso 2 (Estratificación Etiológica):**
 - **HIS menor o igual a 4:** Orientar estudio hacia biomarcadores de Alzheimer (PET amiloide, LCR: Abeta42/p-Tau). Iniciar inhibidores de colinesterasa.
 - **HIS entre 5 y 6:** Solicitar RMN cerebral con secuencias T2/FLAIR para cuantificar leucoaraiosis (escala Fazekas) y microhemorragias (secuencia T2-estrella / SWI). Terapia combinada neuroprotectora y vascular.
 - **HIS mayor o igual a 7:** Priorizar protocolo cardiovascular integral: ecodoppler de troncos supraórticos, Holter cardíaco (descarte de fibrilación auricular), estatinas y control estricto de PA (menor a 130/80 mmHg).
- **Paso 3 (Monitorización Evolutiva):** Reevaluar tras cualquier episodio de empeoramiento brusco o caída injustificada.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN DETERIORO COGNITIVO COMPLEJO

Identificación: Varón de 75 años, fumador con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes tipo 2 mal controladas, derivado por quejas de lentitud mental, dificultades en la marcha y apatía que comenzaron de forma notable tras un episodio de mareo intenso hace 10 meses.

Evaluación con Escala de Isquemia de Hachinski:

• **Puntuación Total HIS = 9 / 18 puntos (Perfil Isquémico / Demencia Vascular).**

• **Ítems Positivos Presentes:** Comienzo brusco (2 pts), Deterioro escalonado (1 pt), Incontinencia emocional (llanto fácil en consulta, 1 pt), Historia de HTA (1 pt), Síntomas neurológicos focales (episodios de torpeza en mano derecha, 2 pts) y Signos focales objetivos (asimetría de reflejos osteotendinosos y marcha a pequeños pasos con base ancha, 2 pts).

Confirmación Neuroimagenológica: La RMN cerebral confirmó leucoencefalopatía vascular isquémica subcortical difusa (Fazekas grado 3) con múltiples infartos lacunares en núcleos de la base y tálamo izquierdo, sin atrofia hipocampal desproporcionada.

Plan Terapéutico: Se instauró antiagregación con Clopidogrel 75 mg/día, optimización antihipertensiva (IECA) y rehabilitación fisioterápica de la marcha, lográndose estabilidad cognitiva plena sin nuevos descensos escalonados a los 12 meses de seguimiento.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

NO SUSTITUYE A LA NEUROIMAGEN:

Una puntuación HIS < 4 no descarta infartos lacunares silentes; siempre solicitar RMN o TC craneal para descartar hematoma subdural crónico o tumores.

ENFERMEDAD DE PEQUEÑO VASO:

La demencia vascular subcortical (Binswanger) puede tener un inicio insidioso sin ictus clínico previo, puntuando falsamente bajo en HIS (4 – 5 pts).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Hachinski, V. C., Iliff, L. D., Zilhka, E., et al. (1975). Cerebral blood flow in dementia. *Archives of Neurology*, 32(9), 632-637.
2. Rosen, W. G., Terry, R. D., Fuld, P. A., Katzman, R., & Peck, A. (1980). Pathological verification of ischemic score in differentiation of dementias. *Annals of Neurology*, 7(5), 486-488.
3. Moris, G., et al. (1995). Utilidad de la escala de isquemia de Hachinski en el diagnóstico diferencial de las demencias. *Neurología*, 10(3), 112-116.
4. Pantoni, L., & Inzitari, D. (1993). The Hachinski Ischemic Score and the diagnosis of vascular dementia: A review. *Neuroepidemiology*, 12(3), 181-188.